

Биологический возраст - это: {
=совокупность морфофункциональных свойств организма, зависящих от индивидуального темпа роста и развития
~период, прожитый ребенком от рождения до момента обследования
~период от зачатия до момента обследования
~период от зачатия до периода полового созревания
~период от зачатия до 19 лет
}

Возрастной период - это отрезок времени, в пределах которого: {
=процессы роста и развития завершены, физиологические особенности неодинаковы, а реакции на раздражители тождественны
~процессы роста и развития завершены, а реакции организма на раздражители тождественны
~физиологические особенности организма достоверно не различаются
~физиологические особенности организма достоверно различаются
~процессы роста и развития не завершены, а реакции организма на раздражители тождественны
}

Индивидуализирующий метод изучения физического развития детей и подростков - это: {
=исследование физического развития одних и тех же детей в течение периода роста и развития
~оценка физического развития индивидуума
~однократное исследование физического развития детей
~многократное исследование физического развития различных детей разных возрастов
~однократное исследование физического развития детей разных этносов по одинаковому стандарту
}

Здоровье детей и подростков - это: {
=гармоничное, соответствующее возрасту развитие, нормальный уровень функции и отсутствие заболеваний и физических дефектов
~состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения
~отсутствие хронических заболеваний и морфо-функциональных отклонений
~отсутствие острых заболеваний и морфо-функциональных отклонений
~соответствие биологического и социального возраста
}

На основании каких данных определяется показатель "индекс здоровья"? {
=отношение числа детей, не болевших в течение года, к общему числу детей
~отношение дней, пропущенных по болезни, к общему числу учебных дней
~отношение числа выявленных случаев заболеваний и функциональных отклонений к числу обследованных детей
~отношение числа детей, болевших более 4 раза в течение года, к общему числу обратившихся в поликлинику детей
~отношение числа детей, не болевших в течение года, к общей численности населения
}

Акселерация включает: {
=ускорение роста и развития
~увеличение продолжительности жизни
~увеличение продолжительности репродуктивного периода
~изменение структуры заболеваемости
~увеличение продолжительности жизни и умственного развития детей
}

Децелерация включает: {
=замедление роста и развития
~снижение продолжительности жизни
~уменьшение продолжительности репродуктивного периода
~снижение продолжительности жизни и веса тела
~замедление психического развития
}

Местные или региональные стандарты физического развития устанавливаются: {
=генерализирующим методом раз в 5-10 лет
~ежегодно в ходе медицинских профилактических осмотров
~ежегодно индивидуализирующим методом
~генерализирующим методом ежегодно
~генерализирующим методом в случае резкого изменения социальных условий
}

В социальной схеме возрастной периодизации выделяют периодов созревания: {
=четыре
~три
~пять
~шесть
~семь
}

Возрастной интервал в дошкольный период составляет до: {
=трех лет
~года
~четырех лет
~1,5 лет
~2,5
}

Возрастной интервал в дошкольный период: {
=3-7 лет
~2-5 лет
~4-8 лет
~0-1
~1-3
}

К третьей группе здоровья относятся дети: {
=больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации
~практически здоровые, но имеющие морфологические и функциональные отклонения
~больные хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации
~больные острыми заболеваниями в стадии декомпенсации
~практически здоровые, имеющие морфологические и функциональные отклонения
}

Соматические показатели включают измерение: {
~%33.33333%роста
~%33.33333%роста, массы тела
~%33.33333%роста, массы тела, окружности грудной клетки, жизненной емкости легких роста, массы тела, окружности грудной клетки
~%-50%роста, массы тела, окружности грудной клетки, проба Штангэ
~%-50%роста, массы тела, проба Мартинэ
}

При соматоскопии определяют: {
=состояние осанки, развитие мускулатуры, форма позвоночника и грудной клетки, ног
~рост сидя и осанку, ЖЕЛ
~осанку, жиротложение, ЧСС
}

~ЧДД, жировое отложение и рост сидя
~окружность грудной клетки и станова́я сила
}

Физиометрические признаки физического развития включают группу показателей: {
=ЖЕЛ, динамометрию, ЧСС, ЧДД, АД
~рост и ЖЕЛ
~динамометрию и рост
~ЖЕЛ, рост и динамометрию
~ЖЕЛ и масса тела
}

О гармоничном физическом развитии детей и подростков судят по соотношению: {
=окружности грудной клетки, длины тела и массы тела
~длины тела и массы тела
~массы тела и окружности грудной клетки
~ЖЕЛ, массы тела и динамометрии
~ЖЕЛ, возраста и динамометрии
}

Какая группа здоровья является группой риска: {
=вторая
~первая
~третья
~четвертая
~пятая
}

Для определения уровня интеллекта у детей и подростков могут быть использованы: {
=тест Векслера
~личностные опросники
~велозргометрию
~ростовесовые показатели
~окружность головы
}

Для определения гармоничности психического развития у детей и подростков могут быть использованы: {
=личностные опросники
~тест Векслера
~велозргометрию
~динамометрию
~массу тела
}

Для изучения физической работоспособности детей и подростков следует использовать: {
=велозргометрия
~личностные опросники
~тест Векслера
~ЖЕЛ
~Массу тела
}

Для определения готовности детей к систематическому обучению в школе следует использовать: {
~%50%тест Керна-Ирасека
~%50%велозргометрия
~%33.33333%динамометрию
~%33.33333%ЖЕЛ
~%33.33333%массу тела
}

К закономерностям роста и развития организма детей относятся: {
~%25%неравномерность темпа роста и развития
~%25%увеличение удельных энергозатрат организма
~%25%половой диморфизм
~%25%обусловленность роста и развития наследственностью и средовыми факторами
}

}

Отбор детей 6-летнего возраста для систематического обучения в школе должен производиться с учетом: {
~%50%морфо-функциональной зрелости организма
~%50%состояния здоровья
~%33.33333%пола
~%33.33333%возраста
~%33.33333%желания родителей
}

Основными неблагоприятными факторами условий обучения в школе являются: {
~%33.33333%повышение температуры и влажности воздуха к концу дня
~%33.33333%рост бактериальной загрязненности воздуха к концу дня
~%33.33333%увеличение содержания органических веществ в воздухе к концу дня
~%50%увеличение уровня шума в течение дня
~%50%ухудшение освещения рабочих мест школьников к концу дня
}

Комплектование специальной медицинской группы осуществляется с учетом: {
~%33.33333%возраста
~%33.33333%клинического диагноза
~%33.33333%физической работоспособности
~%50%пола
~%50%успеваемости по физической культуре
}

Основными компонентами здорового образа жизни являются: {
~%25%соблюдение гигиенических норм и правил режима учебы, труда, отдыха, питания
~%25%оптимальный двигательный режим
~%25%высокая физическая активность
~%25%правильное экологическое поведение
}

К особенностям организации гигиенического воспитания детей дошкольного возраста относятся: {
~%33.33333%использование игровых форм
~%33.33333%участие старших детей в работе по гигиеническому воспитанию младших
~%33.33333%преподавание на уроках в образовательных учреждениях основ гигиены
~%50%использование учебной пособия
~%50%использование лекций
}

Биологический возраст можно установить по следующим данным: {
~%33.33333%длине тела и ее годовым прибавкам
~%33.33333%развитию вторичных половых признаков
~%33.33333%наличию точек окостенения
~%100%ЖЕЛ
}

Оценка физического развития ребенка по комплексной схеме имеет значение для: {
~%33.33333%назначения индивидуальных рекомендаций по профилактике и лечению заболеваний
~%33.33333%оценки состояния здоровья коллектива
~%33.33333%выявление группы риска развития заболевания
~%50%индивидуального нормирования физической и умственной нагрузки
~%50%оценки состояния здоровья индивидуума и его динамики
}

Физическое развитие детей и подростков зависит от: {
~%33.33333%биологических факторов
~%33.33333%социальных факторов
~%33.33333%состояния здоровья
~%50%методов исследования
~%50%методов оценки
}

Наиболее информативны в дошкольном возрасте (4-6 лет) следующие показатели биологического развития: {
~%33.33333%длина тела
~%33.33333%число постоянных зубов
~%33.33333%изменений пропорций телосложения
~%50%погодная прибавка длины тела
~%50%степень развития вторичных половых признаков
}

Наиболее информативны в старшем школьном возрасте (14-17 лет) следующие показатели биологического развития: {
~%50%погодная прибавка длины тела
~%50%степень развития вторичных половых признаков
~%33.33333%длина тела
~%33.33333%число постоянных зубов
~%33.33333%изменение пропорций телосложения
}

Основными путями изучения состояния здоровья детей и подростков являются: {
~%50%выборочные обследования репрезентативных групп
~%50%обобщение результатов массовых осмотров
~%33.33333%эпидемиологическое математическое моделирование
~%33.33333%естественно-гигиенический эксперимент
~%33.33333%Гигиенический лабораторный эксперимент
}

Основными группами показателей, используемых для характеристики общественного здоровья детей и подростков, являются: {
~%25%показатели физического развития различных возрастно-половых групп
~%25%медико-демографические показатели
~%25%данные об инвалидизации детей
~%25%медико-статистические показатели заболеваемости
}

Основными факторами риска, влияющими на состояние здоровья детей, являются: {
~%25%нарушения гигиенических требований к окружающей среде и условиям жизнедеятельности
~%25%наследственность
~%25%нарушение режима дня и учебно-воспитательного процесса
~%25%недостатки в организации и качестве питания
}

Основными экологически обусловленными формами патологии в детской популяции будут: {
~%25%врожденная патология
~%25%аллергические болезни
~%25%бронхолегочная патология
~%25%железодефицитная анемия
}

Анализ состояния здоровья детских и подростковых контингентов проводится по: {
~%25%патологической пораженности
~%25%заболеваемости по обращаемости
~%25%количеству часто болеющих детей
~%25%индексу здоровья
}

Биологический возраст - это: {

=совокупность морфо-функциональных свойств организма, зависящих от индивидуального темпа роста и развития
~период, прожитый ребенком от рождения до момента обследования
~период от зачатия до момента обследования
~период от 7 лет до момента обследования
~период, прожитый ребенком от 5 лет до 19 лет обследования
}

Возрастной период - это отрезок времени, в пределах которого: {
=процессы роста и развития, физиологические особенности организма тождественны, а реакции на раздражители одинаковы
~процессы роста и развития завершены, а реакции на раздражители не отличаются
~физиологические особенности организма достоверно не различаются
~процессы роста и развития завершены, а реакции на раздражители отличаются
~физиологические особенности организма достоверно различаются
}

Индивидуализирующий метод изучения физического развития детей и подростков -это: {
=исследование физического развития одних и тех же детей в течение периода роста и развития
~оценка физического развития индивидуума
~однократное исследование физического развития детей
~однократное исследование физиометрических показателей развития детей
~оценка физического развития коллектива
}

Генерализующий метод изучения физического развития детей подростков -это: {
~оценка физического развития индивидуума
~исследование физического развития одних и тех же групп детей в течении периода роста и развития
=массовое исследование физического развития больших групп детей в относительно короткий срок
~исследование физического развития детей в генеральной совокупности
~исследование физического развития индивидуума в динамике
}

Здоровье детей и подростков - это: {
=гармоничное, соответствующее возрасту развитие, нормальный уровень функций и отсутствие заболеваний и физических дефектов
~состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения
~отсутствие хронических заболеваний и морфо-функциональных отклонений
~отсутствие острых заболеваний и морфо-функциональных отклонений
~отсутствие острых и хронических заболеваний
}

Отбор детей 6-летнего возраста для систематического обучения в школе должен производиться с учетом: {
~%50%морфо-функциональной зрелости организма
~%50%состояния здоровья
~%33.33333%пола
~%33.33333%возраста
~%33.33333%желания родителей
}

Основными неблагоприятными факторами условий обучения в школе являются: {

- ~%33.33333%повышение температуры и влажности воздуха к концу дня
- ~%33.33333%рост бактериальной загрязненности воздуха к концу дня
- ~%33.33333%увеличение содержания органических веществ в воздухе к концу дня
- ~%33.33333%увеличение содержания озона в воздухе к концу дня
- ~%33.33333%увеличение уровня шума в течение дня
- ~%33.33333%ухудшение освещения рабочих мест школьников к концу дня

Комплектование специальной медицинской группы осуществляется с учетом: {

- ~%33.33333%возраста
- ~%33.33333%клинического диагноза
- ~%33.33333%физической работоспособности
- ~%50%пола
- ~%50%успеваемости по физической культуре

На основании, каких данных определяется показатель "индекс здоровья"? {

- =отношение числа детей, не болевших в течение года, к общему числу детей
- ~отношение дней, пропущенных по болезни, к общему числу учебных дней
- ~отношение числа выявленных случаев заболеваний и функциональных отклонений к числу обследованных детей
- ~отношение числа детей, болевших более 4 раз в течение года, к общему числу обратившихся в поликлинику детей
- ~отношение числа детей, не болевших в течение года, к общей численности населения

Местные или региональные стандарты физического развития устанавливаются: {

- =генерализирующим методом раз в 5-10 лет
- ~ежегодно в ходе медицинских профилактических осмотров
- ~ежегодно индивидуализирующим методом
- ~генерализирующим методом ежегодно
- ~генерализирующим методом в случае резкого изменения социальных условий

В социальной схеме возрастной периодизации выделяют периодов созревания: {

- =четыре
- ~три
- ~пять
- ~шесть
- ~семь

Основными компонентами здорового образа жизни являются: {

- ~%25%соблюдение гигиенических норм и правил режима учебы, труда, отдыха, питания
- ~%25%оптимальный двигательный режим
- ~%25%отсутствие вредных привычек
- ~%25%высокая медицинская активность

К особенностям организации гигиенического воспитания детей дошкольного возраста относятся: {

- ~%33.33333%использование игровых форм
- ~%33.33333%участие старших детей в работе по гигиеническому воспитанию младших
- ~%33.33333%преподавание на уроках в образовательных учреждениях основ гигиены
- ~%50%использование наглядной агитации
- ~%50%использование лекций, бесед

}

Возрастная периодизация: {

- ~%33.33333%необходима для организации образовательно-воспитательной деятельности детей разного возраста
- ~%33.33333%необходима для определения возраста поступления ребенка в детское учреждение, начала трудовой деятельности
- ~%33.33333%необходима для гигиенического нормирования факторов окружающей среды
- ~%100%базируется на теории биологической надежности функциональных систем и организма в целом

Биологический возраст можно установить по следующим данным: {

- ~%33.33333%длине тела и ее годовым прибавкам
- ~%33.33333%развитию вторичных половых признаков
- ~%33.33333%наличию точек окостенения
- ~%100%ЖЕЛ

Возрастной интервал в преддошкольный период составляет до: {

- =трех лет
- ~года
- ~четыре лет
- ~пяти лет
- ~семи лет

Возрастной интервал в дошкольный период: {

- =3-7 лет
- ~2-5 лет
- ~4-8 лет
- ~0-1 год
- ~1-2 года

К третьей группе здоровья относятся дети: {

- =больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации
- ~практически здоровые, но имеющие морфологические и функциональные отклонения
- ~больные хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации
- ~здоровые
- ~больные хроническими заболеваниями в субкомпенсированном состоянии,

Соматические показатели включают измерение: {

- =роста, массы тела, окружности грудной клетки, окружности головы
- ~роста, проба Штангэ
- ~роста, массы тела, проба Мартинэ
- ~роста, массы тела, окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, проба Генчи
- ~степени полового развития

Оценка физического развития ребенка по комплексной схеме имеет значение для: {

- ~%33.33333%назначения индивидуальных рекомендаций профилактике и лечению заболеваний
- ~%33.33333%индивидуального нормирования физической и умственной нагрузки
- ~%33.33333%выявление группы риска развития заболевания
- ~%100%оценки состояния здоровья индивидуума и его динамики

Физическое развитие детей и подростков зависит от: {

~%33.33333%биологических факторов
~%33.33333%социальных факторов
~%33.33333%состояния здоровья
~%-50%методов исследования
~%-50%методов оценки
}

Наиболее информативны в дошкольном возрасте (4-6 лет) следующие показатели биологического развития: {
~%33.33333%длина тела
~%33.33333%число постоянных зубов
~%33.33333%изменений пропорций телосложения
~%-50%погодная прибавка длины тела
~%-50%степень развития вторичных половых признаков
}

Наиболее информативны в старшем школьном возрасте (14-17 лет) следующие показатели биологического развития: {
~%50%погодная прибавка длины тела
~%50%степень развития вторичных половых признаков
~%-33.33333%длина тела
~%-33.33333%число постоянных зубов
~%-33.33333%изменение пропорций телосложения
}

Физиометрические признаки физического развития включают группу показателей: {
=ЖЕЛ и динамометрию
~рост и ЖЕЛ
~динамометрию и рост
~состояние опорно-двигательного аппарата
~степень полового созревания
}

О гармоничном физическом развитии детей и подростков судят по соотношению: {
=окружности грудной клетки, длины тела и массы тела
~длины тела и массы тела
~массы тела и окружности грудной клетки
~длины тела и ЖЕЛ
~формы позвоночника и ног
}

Какая группа здоровья является группой риска: {
=вторая
~первая
~третья
~четвертая
~пятая
}

Для определения уровня интеллекта у детей и подростков могут быть использованы: {
=тест Векслера
~личностные опросники
~велозргометрию
~корректирующие таблицы В. Я. Анфимова
~арифметические примеры
}

Для определения гармоничности психического развития у детей и подростков могут быть использованы: {
=личностные опросники
~тест Векслера
~велозргометрию
~методики исследования продолжительности и характера деятельности детей
~методики исследования работоспособности детей
}

Основными путями изучения состояния здоровья детей и подростков являются: {
~%50%обследования репрезентативных групп

~%50%обобщение результатов массовых осмотров
~%-33.33333%эпидемиолого-математическое моделирование:
~%-33.33333%естественно-гигиенический эксперимент
~%-33.33333%клинический метод
}

Основными группами показателей, используемых для характеристики общественного здоровья детей и подростков, являются: {
~%25%показатели физического развития различных возрастно-половых групп
~%25%медико-демографические показатели
~%25%медико-статистические показатели заболеваемости
~%25%данные об инвалидизации детей;
}

Основными факторами риска, влияющими на состояние здоровья детей, являются: {
~%20%нарушения гигиенических требований к окружающей среде и условиям жизнедеятельности
~%20%наследственность
~%20%недостаточная или избыточная двигательная активность;
~%20%нарушение режима дня и учебно-воспитательного процесса
}

Основными экологически обусловленными формами патологии в детской популяции будут: {
~%33.33333%врожденная патология
~%33.33333%аллергические болезни
~%33.33333%железодефицитная анемия
~%-50%новообразования
~%-50%сахарный диабет
}

Дифференциация потребностей в энергии и пищевых веществах в зависимости от пола начинается {
=с 11 лет
~с 7 лет
~с 14 лет
~с 18 лет
}

Основоположником гигиены детей и подростков является: {
= Ф.Ф.Эрисман;
~А.П.Доброславин;
~М.Я.Мудров;
~Н.А.Тольский;
~Г.Н.Сердюковская.
}

Основные принципы нормирования в гигиене детей и подростков были сформулированы: {
= С.М.Громбахом
~Ф.Ф.Эрисманом
~Н.А. Тольским
~Г.В. Хлопиным
~П.К.Анохиным
}

Для оценки физического развития детей и подростков вычисляют возраст обследуемого с точностью до: {
= дней;
~часов;
~месяцев;
~лет;
~минут.
}

Длительно болеющими считаются дети, у которых длительность одного заболевания составляла более: {
= 25 дней;

~5 дней;
~15 дней;
~20 дней;
~10 дней.
}

Уровень заболеваемости детей в сравнении со взрослыми: {
= выше;
~ниже;
~одинаковый;
~выше лишь по распространенности хронических заболеваний;
~ниже лишь по сравнению с пенсионным контингентом.
}

Основными экологически обусловленными формами патологии в детской популяции являются: {
~%25% врожденная патология новорожденных;
~%25% новообразования;
~%25% аллергические болезни;
~%25% бронхолегочная патология;
~%-100%профзаболевания.
}

Тест Керна-Ирасека для оценки психофизиологической зрелости состоит из следующих заданий: {
= нарисовать человека, срисовать рукописную фразу и группу точек;
~нарисовать человека, написать фразу, срисовать группу точек;
~срисовать человека, рукописную фразу и группу точек;
~нарисовать человека, написать под диктовку фразу, срисовать группу точек;
~нарисовать человека, животного, срисовать группу точек.
}

Принципами организации ступенчатого режима для первоклассников являются: {
~%50% постепенное увеличение длительности урока от 30 до 45 минут на протяжении учебного года;
~%50% постепенное увеличение числа уроков;
~%-33.33333%сокращение длительности урока до 30 минут на протяжении всего учебного года;
~%-33.33333%сокращение числа уроков до 3-х;
~%-33.33333%постепенное укорочение перемен.
}

В норме адаптация к систематическому обучению наступает: {
= к концу 1 четверти обучения;
~к концу 1 недели обучения;
~к концу 1 месяца обучения;
~к концу 1 полугодия обучения;
~к концу 1 года обучения.
}

Облегченным днем недели для учащихся начальной школы должен быть: {
= среда;
~понедельник;
~вторник;
~четверг;
~пятница.
}

Плотность занятия определяется как отношение: {
= времени учебной работы учащегося к общему времени занятия;
~времени самостоятельной работы учащегося к общему времени занятия;
~времени отвлечений учащегося к общему времени занятия;
~времени активного внимания учащегося к общему времени занятия;

~времени занятий физическими упражнениями к общему времени занятия.
}

Наиболее неблагоприятные изменения функционального состояния студентов отмечаются на: {
= 1 курсе
~3 курсе
~4 курсе
~5 курсе
}

Медицинский контроль за физическим воспитанием в образовательных учреждениях включает: {
~%25%наблюдение за состоянием и динамикой здоровья учащихся;
~%25%определение группы физического воспитания;
~%25%наблюдение за нагрузкой;
~%25%контроль за условиями проведения физического воспитания;
~%-100%контроль за уровнем физической подготовленности;
}

Первая врачебно-профессиональная консультация должна быть проведена: {
= в 5-6 классе;
~при поступлении в детское дошкольное учреждение;
~при поступлении в школу;
~в 8-9 классе;
~в 10-11 классе.
}

Особенности обмена веществ у детей и подростков: {
~%33.33333% наибольшая интенсивность основного обмена;
~%33.33333% относительно высокий расход энергии;
~%33.33333% преобладание анаболических процессов.
~%-50%наименьшая интенсивность основного обмена;
~%-50%относительно низкий расход энергии;
}

К нарушениям, характерным на современном этапе для питания детей и подростков относятся: {
~%33.33333% дефицит животных белков;
~%33.33333% дефицит полиненасыщенных жирных кислот;
~%33.33333% дефицит пищевых волокон;
~%-50%дефицит животных жиров;
~%-50%дефицит углеводов.
}

Для профилактики йодной недостаточности в регионах, дефицитных по йоду, следует предусматривать: {
~%25% рационализацию структуры питания;
~%25% йодирование воды;
~%25% йодирование соли;
~%25% йодирование пищевых продуктов, применяемых для питания детей и подростков;
~%-100%терапию йодидом калия.
}

Выдача санитарно-эпидемиологических заключений на проекты строительства и реконструкции учреждений для детей и подростков осуществляется: {
= сотрудниками территориальных управлений Федеральной службы Роспотребнадзора;
~сотрудниками федеральных государственных учреждений «Центр гигиены и эпидемиологии»;
~руководителями учреждений для детей и подростков;
~медицинскими работниками учреждений для детей и подростков.
}

Обеспечение принципа групповой изоляции при проектировании дошкольного образовательного учреждения достигается: {
~%33.33333%применением зеленых насаждений в качестве разделителей площадок;
~%33.33333%наличием у каждой группы игровой площадки;
~%33.33333%наличием у каждой группы ячейки с полным набором помещений;
~%-50%достаточностью площади основных помещений для детей;
~%-50%применением блочной композиции здания с отдельным входом для каждой группы.
}

Местная вытяжная вентиляция необходима в следующих помещениях общеобразовательных учреждений: {
~%33.33333% кабинете химии.
~%33.33333% пищеблоке;
~%33.33333% мастерских.
~%-50%рекреациях;
~%-50%гимнастическом зале;
}

Школьная мебель делится на группы с учетом: {
=длины тела детей;
~возраста детей;
~пола детей;
~состояния здоровья детей;
~окружности груди
}

При расстановке школьной мебели в классе основной световой поток должен падать на рабочее место: {
=слева;
~справа;
~спереди;
~сзади;
~направление светового потока значения не имеет.
}

Кегль шрифта - это: {
=размер шрифта в типографских пунктах;
~рисунок шрифта;
~количество знаков, уместяющихся в строке длиной 1 квадрат;
~оптическая плотность элементов изображения;
~количество рисунков.
}

Игрушки для детей до года должны обеспечивать у ребенка: {
~%33.33333%развитие зрительного анализатора;
~%33.33333%развитие слухового анализатора;
~%33.33333%развитие движений пальцев рук;
~%-50%возможность сюжетных игр;
~%-50%возможность ролевых игр.
}

При производстве детской обуви нормируется: {
~%33.33333%гибкость подошвы;
~%33.33333%высота каблука;
~%33.33333%масса обуви;
~%-50%толщина стельки;
~%-50%высота обуви.
}